Bitácora Médica de Guardia

Periodo: 10/11/2026 AL 11/11/2026 | Hospitalización, Periféricos y Emergencia

AUTHOR
MD MORAN (PG Reumatología IRM), MD GOMEZ (PG Medicina Interna)

PUBLISHED
November 10, 2026

Resumen Ejecutivo de la Guardia

ⓘ **Censo Operativo:** Total: **42** pacientes | Hospitalizados: **18** | Periféricos: **12** | Emergencia/Obs: **12** | Nuevos ingresos de guardia: **1**

Accesos Rápidos: Cultivos intranet | Programacion quirurgica

Checklist de la Visita Nocturna (Pendientes Críticos)

> [!IMPORTANT] Esta lista compila todas las tareas con horario crítico, exámenes STAT, controles de madrugada y cambios farmacológicos programados para el equipo de guardia.

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
URGENTE	6A	RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL (HC 2013397)	Evaluar fin de ciclo de antibiótico (Día 5/5)	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	6C	ALMEIDA JARAMILLO JUAN CARLOS (HC 2086486)	Insistir reporte TAC cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	6D	LOPEZ PAZMINO RICARDO DARIO (HC 2199041)	Segunda curva de Troponina ultrasensible a las 22:00 + EKG	`22:00`	☐ Pendiente
CONTROL	7	VINUEZA ROJAS ARTURO	Control lunes de BH, Urea, Creatinina y Electrolitos	`05:00 AM`	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
		MIGUEL (HC 239902)			
URGENTE	7	VINUEZA ROJAS ARTURO MIGUEL (HC 239902)	Aspiración de secreciones traqueales y curación por clínica de heridas	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	8	OÑA TELLO JOSELYN CAROLINA (HC 1719421)	Verificar valoración y seguimiento por Comité de Bioética	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	8	OÑA TELLO JOSELYN CAROLINA (HC 1719421)	Auditar indicaciones de Clínica del Dolor (Dra. Galiano) y Coloproctología	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
STAT	9A	ROSAS CORREA MARIA ESTHER (HC 124595)	Verificar preparación quirúrgica y programación QX hoy	STAT / 20:00	☐ Pendiente
CONTROL	9B	CARRERA AGUIRRE MARTHA GRACIELA (HC 2045964)	CONTROL ESTRICTO DE ELECTROLITOS MAÑANA A LAS 05:00 AM	05:00 AM	☐ Pendiente
URGENTE	9B	CARRERA AGUIRRE MARTHA GRACIELA (HC 2045964)	Verificar tolerancia a nutrición enteral y residuos gástricos	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
STAT	9C	MORENO BARRIGA BLANCA ALICIA (HC 1734898)	CONTROL DE ELECTROLITOS Y POTASIO SERICO STAT	STAT / 21:00	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
URGENTE	**9C**	MORENO BARRIGA BLANCA ALICIA (HC 1734898)	Pendiente informe de TAC simple de cráneo y UroTAC	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**9C**	MORENO BARRIGA BLANCA ALICIA (HC 1734898)	Insistir derivación a IRM de Nefrología para perfil de glomerulopatías	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	**9D**	BARAHONA ALOBUELA DOLORES (HC 1021400)	RESONANCIA MAGNÉTICA SIMPLE Y CONTRASTADA DE ENCÉFALO (Orden 34934990) PENDIENTE REALIZAR	`STAT / Coordinar`	☐ Pendiente
URGENTE	**9D**	BARAHONA ALOBUELA DOLORES (HC 1021400)	Evaluar suspensión de Ampicilina/Sulbactam y Claritromicina al completar hoy 5/5 días	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**10A**	HERRERA OBANDO JESUS RAQUEL (HC 797237)	Insistir resultado de biopsia EBUS + crioterapia + biomolecular de lesión pulmonar (SOLCA)	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	**10A**	HERRERA OBANDO JESUS RAQUEL (HC 797237)	Rx de control evolutiva y gasometría de control por SDRA	`STAT / 21:00`	☐ Pendiente
STAT	**10B**	REYES SANCHEZ INES MAGDALENA (HC 8140)	TOMAR HEMOCULTIVOS X 2 EN CASO DE ALZA TÉRMICA	`STAT PRN FIEBRE`	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
URGENTE	10B	REYES SANCHEZ INES MAGDALENA (HC 8140)	Electrocardiograma STAT de control y diario por flutter auricular	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
CONTROL	10B	REYES SANCHEZ INES MAGDALENA (HC 8140)	Control de laboratorio 05:00 AM: Biometría, Creatinina, Urea, Electrolitos	`05:00 AM`	☐ Pendiente
STAT	10C	CHANGO GADVAY MARIA ADELAIDA (HC 1996362)	Pendiente resultados de RMN unión cráneo-cervical	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
CONTROL	10C	CHANGO GADVAY MARIA ADELAIDA (HC 1996362)	Control de Electrolitos y Magnesio a las 18h00 / control nocturno	`18:00 / 22:00`	☐ Pendiente
STAT	10C	CHANGO GADVAY MARIA ADELAIDA (HC 1996362)	Manejo urgente de dolor a nivel genital de gran intensidad	`STAT`	☐ Pendiente
STAT	11A	NICOLALDE CENTENO CESAR ENRIQUE (HC 554153)	Monitoreo horario de glicemia capilar por hipoglicemia refractaria	`Horario (c/2 horas)`	☐ Pendiente
URGENTE	11A	NICOLALDE CENTENO CESAR ENRIQUE (HC 554153)	Pendiente agendar turno Body TAC y TAC con protocolo de páncreas (Orden 34926151)	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
STAT	11B	PACHACAMA SUNTAXI FREDDY RODRIGO (HC 20CELI84974)	Preparación para broncoscopia y colocación de drenaje torácico MAÑANA	`STAT / NPO 24:00`	☐ Pendiente
STAT	12A	CALDERON ALMEIDA SIMON BOLIVAR (HC 2007245)	TOMAR HEMOCULTIVOS X 2 ANTE PICO FEBRIL + Laboratorio central de proteínas y perfil hepático	`STAT PRN`	☐ Pendiente
URGENTE	12A	CALDERON ALMEIDA SIMON BOLIVAR (HC 2007245)	Coordinar Body TAC para búsqueda de foco infeccioso primario	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	INFECTO 1B	ANDRANGO SIMBAÑA GONZALO (HC 307712)	Verificar reserva y alistamiento de 2 paquetes globulares y 2 plasmas congelados para cirugía	`STAT / 20:30`	☐ Pendiente
CONTROL	INFECTO 1B	ANDRANGO SIMBAÑA GONZALO (HC 307712)	Control diario de electrolitos y hematocrito prequirúrgico	`05:00 AM`	☐ Pendiente
STAT	CARDIO 3C	HIDALGO NIETO CARLOS GONZALO (HC 963279)	Verificar preparación colónica adecuada para EDA y COLONOSCOPIA MAÑANA 10/11/2026	`21:00`	☐ Pendiente
URGENTE	CARDIO 3C	HIDALGO NIETO CARLOS GONZALO (HC 963279)	Hacer informar TAC simple de encéfalo, cuello, tórax, abdomen y pelvis	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
CONTROL	CARDIO 4B	GALEAS LOPEZ ROSA	Continuar fisioterapia respiratoria. Si persiste requerimiento de O2,	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
		ELVIRA (HC 1814762)	reinterconsultar Neumología con gasometría		
CONTROL	**NEUMO 8B**	RODRIGUEZ QUIÑONEZ FRANKLIN (HC 2087745)	CONTROL DIARIO DE ELECTROLITOS Y SODIO	`05:00 AM`	☐ Pendiente
URGENTE	**NEUMO 8B**	RODRIGUEZ QUIÑONEZ FRANKLIN (HC 2087745)	Nueva biopsia percutánea por radiointervencionismo pendiente turno	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
CONTROL	**NEUMO GOMEZ**	GOMEZ ALMEIDA MARIO RENE (HC 1274973)	EMO POR SONDA VESICAL A LAS 05:00 AM + Biometría, PCR, Azoados	`05:00 AM`	☐ Pendiente
URGENTE	**NEUMO GOMEZ**	GOMEZ ALMEIDA MARIO RENE (HC 1274973)	Auditar respuesta de interconsultas: Neurocirugía, Traumatología y Radioterapia	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**NEUMO GOMEZ**	GOMEZ ALMEIDA MARIO RENE (HC 1274973)	Fin de esquema de Piperacilina/Tazobactam (Día 5/5): valorar retiro o cambio por Proteus BLEE	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
CONTROL	**UROLOGIA HARO**	HARO PRADO DANNY ERNESTO (HC 650799)	Control domingo de PCR, Biometría, Electrolitos, Urea y Creatinina	`05:00 AM`	☐ Pendiente
STAT	**ER TORRES**	TORRES CEVALLOS CESAR WASHINGTON (HC 558292)	GASOMETRÍA ARTERIAL STAT + CONTROL ESTRICTO DE SODIO Y ELECTROLITOS	`STAT / 20:30`	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
STAT	**INTERMEDIOS CAMACHO**	CAMACHO PINEDA RICAURTE DE JESUS (HC 2087368)	CONTROL DE ELECTROLITOS CADA 12 HORAS ESTRICTO	`21:00`	☐ Pendiente
URGENTE	**INTERMEDIOS CAMACHO**	CAMACHO PINEDA RICAURTE DE JESUS (HC 2087368)	Curación de úlceras por presión por clínica de heridas	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	**AB 3B**	MOSQUERA SALVADOR PATRICIA ALEXANDRA (HC 1334681)	Gasometría arterial STAT + Ácido láctico	`STAT / 20:00`	☐ Pendiente
URGENTE	**AB 3B**	MOSQUERA SALVADOR PATRICIA ALEXANDRA (HC 1334681)	Coprorasitario + PMN + Toxinas A y B para Clostridium difficile	`21:00`	☐ Pendiente
STAT	**AB 3B**	MOSQUERA SALVADOR PATRICIA ALEXANDRA (HC 1334681)	Urocultivo tomar muestra STAT	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	**ER-AB 1**	MOLINA MURILLO MARIA JOSE (HC 1304188)	EMO, Gram y UROCULTIVO STAT (¡Muestra vesical estricta, NO de nefrostomías!)	`STAT / Inmediato`	☐ Pendiente
STAT	**ER-AB 1**	MOLINA MURILLO MARIA JOSE (HC 1304188)	Electrocardiograma STAT en este momento	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**ER-AB 1**	MOLINA MURILLO	Criterio de alarma: Si descompensación	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
		MARIA JOSE (HC 1304188)	neurológica/hemodinámica solicitar valoración UCI		
STAT	**ABREVIADOS CANTOS**	CANTOS AGUIRRE GUADALUPE ESPERANZA (HC 140019)	Gasometría arterial en este momento + Electrolitos hoy PM	`STAT / 20:00`	☐ Pendiente
CONTROL	**ABREVIADOS CANTOS**	CANTOS AGUIRRE GUADALUPE ESPERANZA (HC 140019)	Control lunes: Biometría, PCR, Urea, Creatinina, Glucosa, Electrolitos urinarios	`05:00 AM`	☐ Pendiente

Mapa Microbiológico y Aislamientos de Alerta

Cama	Paciente	Muestra	Microorganismo	Patrón / Resistencia	Terapia Sugerida / Sensible
8	OÑA TELLO JOSELYN CAROLINA	Urocultivo	*Proteus mirabilis*	**Resistente a Gentamicina, TMP/SMX, Ciprofloxacino**	Amikacina, Ceftriaxona, Cefazolina
9A	ROSAS CORREA MARIA ESTHER	Líquido ascítico	*Pseudomonas aeruginosa*	**Resistente a Carbapenémicos (impermeabilidad)**	Colistina, Aminoglucósidos según MIC
11B	PACHACAMA SUNTAXI FREDDY RODRIGO	Líquido Pleural	*Salmonella enterica ssp enterica*	**Sensible**	Ceftriaxona, Ciprofloxacino
INFECTO 1B	ANDRANGO SIMBAÑA GONZALO	Hemocultivo	*Enterococcus faecalis*	**Sensible a Bencilpenicilina y Ampicilina**	Bencilpenicilina, Ampicilina
NEUMO GOMEZ	GOMEZ ALMEIDA MARIO RENE	Urocultivo	*Proteus mirabilis*	**Productor de BLEE (Betalactamasas**	Carbapenémicos, Amikacina

Cama	Paciente	Muestra	Microorganismo	Patrón / Resistencia	Terapia Sugerida / Sensible
				de espectro extendido)	
ER-AB 1	MOLINA MURILLO MARIA JOSE	Urocultivo	*Klebsiella pneumoniae*	**BLEE positivo**	Meropenem, Amikacina
ABREVIADOS CANTOS	CANTOS AGUIRRE GUADALUPE ESPERANZA	Urocultivo	*Klebsiella pneumoniae*	**BLEE positivo**	Meropenem, Amikacina

Detalle Clínico por Áreas y Camas

Hospitalización (15 pacientes) Periféricos (6 pacientes)

Emergencia / Observación (5 pacientes)

Cama 6A: RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL CKD-EPI: 84 ml/min/1.73m2

- **HC:** `2013397` | **Cédula:** 1709777906 | **Edad:** 59 años | **Sexo:** M
- **Antecedentes (APP):** Hipotiroidismo; Hipertensión arterial; Neumonía asociada a la comunidad (oct/2026); Artritis reumatoide en seguimiento por Reumatología IESS

Diagnósticos Activos:

- Neumonía adquirida en la comunidad (CIE-10: J15.9)
- Choque séptico de foco pulmonar superado (CIE-10: R57.2)
- Insuficiencia renal aguda KDIGO C3 (CIE-10: N17.9)

Soporte y Vía: - *Dieta:* Dieta general blanda - *Hidratación / Infusiones:* Dispositivo salinizado sin heparina

Medicación Activa:

- Ampicilina / Sulbactam 3 g IV c/6 horas 5/5
- Paracetamol 1 g VO c/8 horas
- Omeprazol 40 mg IV cada día
- Enoxaparina 60 mg SC cada día
- Levotiroxina 50 mcg VO cada día 06:00
- Tramadol 50 mg IV c/6 horas diluido lento

- Hidrocortisona 150 mg IV cada día 08:00 AM

Pendientes:

- ☑ STAT **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** Electrocardiograma (EKG) STAT
- ☑ STAT **[LABORATORIO]** Gasometría arterial STAT + Electrolitos
- ☐ URGENTE **[FARMACO_DOSIS]** Evaluar fin de ciclo de antibiótico (Día 5/5)

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-06 (BH y Química):* leucocitos: 2.52, hemoglobina: 10.4, hematocrito: 32.3, plaquetas: 84000, inr: 1.05, creatinina: 0.8

Observaciones / Novedades:

> Urea 10% semisólido cutáneo tópico BID por 15 días en manos. Laboratorios reumatología orden 34926920.

Cama 6C: ALMEIDA JARAMILLO JUAN CARLOS ⚠ ALERGIA: POLLO, ARÁNDANOS, AVENA CKD-EPI: 103.42 ml/min/1.73m2

- **HC:** `2086486` | **Cédula:** 1705956132 | **Edad:** 65 años | **Sexo:** M
- **Antecedentes (APP):** Hipertensión arterial (2004); Diabetes mellitus (2014); Cefalea; Dolor miembro superior derecho

Diagnósticos Activos:

- Adenopatías generalizadas en estudio
- Hipertensión arterial
- Diabetes mellitus tipo 2
- Síndrome constitucional en estudio

Soporte y Vía: - *Dieta:* Dieta hiposódica y para diabético fraccionada en 5 tomas (EXCLUIR POLLO, ARÁNDANO Y AVENA) - *Hidratación / Infusiones:* Dispositivo salinizado sin heparina

Medicación Activa:

- Amlodipino 5 mg VO QD PM
- Amitriptilina 25 mg VO QD PM
- Insulina Glargina 8 UI SC cada mañana
- Enoxaparina 40 mg SC cada día

Pendientes:

- ☐ URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** Insistir reporte TAC cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis

☐ RUTINA **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** Insistir ecografía de tiroides y EDA/Colonoscopia

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-06 (BH y Bioquímica):* hemoglobina_glicosilada: 9.96, glucosa: 135, creatinina: 0.63, plaquetas: 255000

Observaciones / Novedades:

> Alerta estricta de alergia alimentaria a nutrición.

Cama 6D: LOPEZ PAZMINO RICARDO DARIO ⚠ ALERGIA: PENICILINA CKD-EPI: 95 ml/min/1.73m2

- **HC:** `2199041` | **Cédula:** 1711223344 | **Edad:** 48 años | **Sexo:** M
- **Antecedentes (APP):** Hipertensión arterial
- **Quirúrgicos (AQX):** Apendicectomía

Diagnósticos Activos:

- Crisis hipertensiva tipo urgencia

Soporte y Vía: - *Dieta:* Hiposódica estricta - *Hidratación / Infusiones:* Vía salinizada

Medicación Activa:

- Amlodipino 10 mg VO cada día

Pendientes:

☐ STAT **[LABORATORIO]** Segunda curva de Troponina ultrasensible a las 22:00 + EKG (`22:00`)

Observaciones / Novedades:

> Nuevo ingreso de guardia.

Cama 7: VINUEZA ROJAS ARTURO MIGUEL CKD-EPI: 35.99 ml/min/1.73m2 (Creatinina 1.78)

- **HC:** `239902` | **Cédula:** N/R | **Edad:** 77 años | **Sexo:** M
- **Antecedentes (APP):** Hipertensión arterial (30 años); Dislipidemia; Enfermedad renal crónica; Craneotomía con evacuación de hematoma subdural
- **Quirúrgicos (AQX):** Craniectomía descompresiva (sept 2026)

Diagnósticos Activos:

- Traqueítis en portador de traqueóstomo
- Hipertensión arterial
- Enfermedad renal crónica estadio 3B (TFG CKD-EPI 31.84)
- Infección de herida quirúrgica frontoparietal + empiema superado

Soporte y Vía: - *Dieta:* Dieta enteral 300cc ART + Diben 900kcal/600cc por gastrostomía - *Hidratación / Infusiones:* O2 por cánula nasal para SatO2 > 85%

Medicación Activa:

- Levetiracetam 500 mg Gastrostomía c/12 horas
- Enoxaparina 40 mg SC QD
- Buscapina 1 tableta Gastrostomía c/8 horas

Pendientes:

- [ ] CONTROL **[LABORATORIO]** Control lunes de BH, Urea, Creatinina y Electrolitos (`05:00 AM`)
- [ ] URGENTE **[CUIDADO_ENFERMERIA]** Aspiración de secreciones traqueales y curación por clínica de heridas

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-02 (BH y Creatinina):* leucocitos: 7.99, hemoglobina: 12.4, creatinina: 1.78

Observaciones / Novedades:

> Gram de secreción traqueal reportó bacilos gramnegativos.

Cama 8: OÑA TELLO JOSELYN CAROLINA CKD-EPI: 70.4 ml/min/1.73m2

- **HC:** `1719421` | **Cédula:** 1719421001 | **Edad:** 30 años | **Sexo:** F
- **Antecedentes (APP):** Síndrome de Gardner; Artritis reumatoide CCP positivo; Poliposis adenomatosa; Colectomía total + ileostomía (2023)
- **Quirúrgicos (AQX):** Colectomía total íleo-recto anastomosis

Diagnósticos Activos:

- Infección de partes blandas
- Infección urinaria Tumbarello 5 puntos en resolución
- Dolor crónico exacerbado
- Proctorragia superada

Soporte y Vía: - *Dieta:* Adecuada para ileostomía - *Hidratación / Infusiones:* Solución salina 0.9% 1000 ml a 20 ml/h

Medicación Activa:

- Oxacilina 2 g IV c/4 horas Día 4
- Prednisona 5 mg VO cada día
- Carvedilol 12.5 mg VO c/12 horas

Pendientes:

- [ ] URGENTE **[INTERCONSULTA]** Verificar valoración y seguimiento por Comité de Bioética
- [ ] URGENTE **[INTERCONSULTA]** Auditar indicaciones de Clínica del Dolor (Dra. Galiano) y Coloproctología

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-06 (PCR y Hemograma):* pcr: 68.6, leucocitos: 9.82, hemoglobina: 10.7

Observaciones / Novedades:

> Seguimiento estricto de débito de ileostomía.

Cama 9A: ROSAS CORREA MARIA ESTHER CKD-EPI: 68 ml/min/1.73m2

- **HC:** `124595` | **Cédula:** 0600433312 | **Edad:** 83 años | **Sexo:** F
- **Antecedentes (APP):** Cardiopatía isquémica con 2 stents; Hipotiroidismo; Hemorragia vítrea
- **Quirúrgicos (AQX):** Histerectomía; Colecistectomía; Safenectomía

Diagnósticos Activos:

- Cáncer de ovario con índice ROMA 97.9 (Alto riesgo)
- Peritonitis bacteriana secundaria
- Derrame pleural derecho resuelto

Soporte y Vía: - *Dieta:* NPO prequirúrgico - *Hidratación / Infusiones:* Dextrosa 5% en SS 0.9% 1000 ml IV a 60 cc/h

Medicación Activa:

- Ampicilina 2 g IV c/4 horas Día 7
- Enoxaparina 60 mg SC QD

Pendientes:

- [ ] STAT **[ADMINISTRATIVO_QX]** Verificar preparación quirúrgica y programación QX hoy (`STAT / 20:00`)
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** Pendiente resultado de citología de bloque celular e inmunohistoquímica

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-07 (Gasometría y Química):* lactato: 1.2, sodio: 129.0, potasio: 4.2, creatinina: 0.68

Observaciones / Novedades:

> Cultivo líquido ascítico: Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos.

Cama 9B: CARRERA AGUIRRE MARTHA GRACIELA

CKD-EPI: 75 ml/min/1.73m2

- **HC:** `2045964` | **Cédula:** 1702915719 | **Edad:** 88 años 2 meses | **Sexo:** F
- **Antecedentes (APP):** Demencia no especificada; Hipertensión arterial; Pénfigo vulgar; Trastorno bipolar

Diagnósticos Activos:

- Trastorno deglutorio severo por demencia
- Anemia moderada macrocítica (Hb 7.5)
- Zona de presión en sacro en cicatrización
- Hipernatremia severa hipovolémica superada

Soporte y Vía: - *Dieta:* Dieta por SNG según indicación de Nutrición - *Hidratación / Infusiones:* Agua libre por SNG 200 ml c/8h

Medicación Activa:

- Ácido Valproico 250 mg tab VO (por SNG) BID por 10 días
- Risperidona 5 gotas VO (por SNG) TID

Pendientes:

- [ ] CONTROL **[LABORATORIO]** CONTROL ESTRICTO DE ELECTROLITOS MAÑANA A LAS 05:00 AM (`05:00 AM`)
- [ ] URGENTE **[CUIDADO_ENFERMERIA]** Verificar tolerancia a nutrición enteral y residuos gástricos

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-08 (BH):* hemoglobina: 7.5, hematocrito: 22.7, leucocitos: 4.83

Observaciones / Novedades:

> Mantener cabecera a 45 grados por alto riesgo de aspiración.

Cama 9C: MORENO BARRIGA BLANCA ALICIA **CKD-EPI: 55.2 ml/min/1.73m2**

- **HC:** `1734898` | **Cédula:** 0500728902 | **Edad:** 72 años | **Sexo:** F
- **Antecedentes (APP):** ACV isquémico territorios múltiples; Insuficiencia cardíaca FEVI preservada 60%; Estenosis aórtica severa NYHA II; Síndrome nefrótico en estudio

Diagnósticos Activos:

- Insuficiencia cardíaca valvular descompensada
- Síndrome nefrótico en estudio
- Hipopotasemia severa recurrente (K 2.44)

Soporte y Vía: - *Dieta:* Hiposódica estricta - *Hidratación / Infusiones:* Restricción hídrica

Medicación Activa:

- Citrato de Potasio 2 cápsulas VO c/8 horas
- Furosemida 20 mg IV c/12 horas **[SUSPENDIDO]**
- Atorvastatina 40 mg VO QD

Pendientes:

- [ ] STAT **[LABORATORIO]** CONTROL DE ELECTROLITOS Y POTASIO SERICO STAT (`STAT / 21:00`)
- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** Pendiente informe de TAC simple de cráneo y UroTAC
- [ ] URGENTE **[INTERCONSULTA]** Insistir derivación a IRM de Nefrología para perfil de glomerulopatías

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-08 (Electrolitos):* potasio: 2.44, sodio: 142.9, cloro: 112, creatinina: 1.05

Observaciones / Novedades:

> Furosemida suspendida por hipokalemia grave recurrente.

Cama 9D: BARAHONA ALOBUELA DOLORES **CKD-EPI: 78.14 ml/min/1.73m2**

- **HC:** `1021400` | **Cédula:** 1703630655 | **Edad:** 77 años | **Sexo:** F
- **Antecedentes (APP):** Insuficiencia suprarrenal primaria; Hipertensión arterial; IAM lateral y diafragmático; Aneurisma cerebral
- **Quirúrgicos (AQX):** Túnel carpiano derecho

Diagnósticos Activos:

- Insuficiencia respiratoria aguda
- Neumonía grave en comunidad (CURB-65 3 puntos)
- Insuficiencia suprarrenal primaria descompensada
- DHE corregido

Soporte y Vía: - *Dieta:* Blanda para diabético - *Hidratación / Infusiones:* Dextrosa en SS 0.9% 1000 ml a 40 ml/h

Medicación Activa:

- Ampicilina / Sulbactam 3 g IV c/8 horas 5/5
- Claritromicina 500 mg IV c/12 horas 5/5
- Hidrocortisona 50 mg IV c/8 horas Día 5
- Fludrocortisona 0.1 mg VO cada mañana Día 3

Pendientes:

- [ ] STAT **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** RESONANCIA MAGNÉTICA SIMPLE Y CONTRASTADA DE ENCÉFALO (Orden 34934990) PENDIENTE REALIZAR (`STAT / Coordinar`)
- [ ] URGENTE **[FARMACO_DOSIS]** Evaluar suspensión de Ampicilina/Sulbactam y Claritromicina al completar hoy 5/5 días
- [ ] RUTINA **[INTERCONSULTA]** Reinterconsultar a Otorrinolaringología para test de deglución

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-08 (Control Glucosa y Electrolitos):* glucosa: 83, sodio: 145.0, potasio: 3.53, cloro: 123

Observaciones / Novedades:

> Conjuntivitis mucopurulenta en tratamiento con Tobramicina/Dexametasona.

Cama 10A: HERRERA OBANDO JESUS RAQUEL

CKD-EPI: 82.3 ml/min/1.73m2

- **HC:** `797237` | **Cédula:** 1709863706 | **Edad:** 60 años | **Sexo:** F
- **Antecedentes (APP):** Déficit de proteína C; Trombosis venosa profunda previa; EPID; Cardiopatía isquémica; ECV; Artritis reumatoidea

Diagnósticos Activos:

- Masa pulmonar en estudio a descartar neoplasia
- Insuficiencia respiratoria aguda PAFI 60 mmHg (SDRA grave)
- Trombosis venosa profunda poplítea, solear y gemelar izquierda
- Lesión lítica de L4 (posible sarcoma paravertebral)

Soporte y Vía: - *Dieta:* Blanda fraccionada - *Hidratación / Infusiones:* Solución salina 0.9% 1000 ml + 10 mEq KCl a 40 ml/h

Medicación Activa:

- Meropenem 1 g IV c/8 horas 4/5
- Enoxaparina 60 mg SC c/12 horas (dosis terapéutica por TVP)
- Morfina 20 mg en 98 ml SS 0.9% IV a 8 ml/h en infusión continua

Pendientes:

- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** Insistir resultado de biopsia EBUS + crioterapia + biomolecular de lesión pulmonar (SOLCA)
- [ ] STAT **[LABORATORIO]** Rx de control evolutiva y gasometría de control por SDRA (`STAT / 21:00`)

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-08 (BH y Plaquetas):* leucocitos: 13.78, hemoglobina: 9.5, plaquetas: 197000, neutrofilos: 11.38

Observaciones / Novedades:

> Infusión continua de morfina por dolor intenso de lesión lítica L4.

Cama 10B: REYES SANCHEZ INES MAGDALENA

CKD-EPI: 42 ml/min/1.73m2

- **HC:** `8140` | **Cédula:** 1703334647 | **Edad:** 79 años | **Sexo:** F
- **Antecedentes (APP):** Hipertensión arterial; Diabetes mellitus tipo 2; Hipotiroidismo; Flutter auricular de conducción variable; Linfoma en remisión

Diagnósticos Activos:

- Choque séptico de foco pulmonar superado
- Trombosis venosa profunda miembro inferior derecho
- Flutter auricular de conducción variable

Soporte y Vía: - *Dieta:* Dieta para diabético hiposódica - *Hidratación / Infusiones:* Cloruro de sodio 0.9% 1000 ml a 40 ml/h

Medicación Activa:

- Enoxaparina 60 mg SC c/12 horas
- Bisoprolol 5 mg VO c/12 horas
- Furosemida 20 mg IV c/12 horas

Pendientes:

- [ ] STAT **[LABORATORIO]** TOMAR HEMOCULTIVOS X 2 EN CASO DE ALZA TÉRMICA (`STAT PRN FIEBRE`)
- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** Electrocardiograma STAT de control y diario por flutter auricular
- [ ] CONTROL **[LABORATORIO]** Control de laboratorio 05:00 AM: Biometría, Creatinina, Urea, Electrolitos (`05:00 AM`)

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-07 (Renal y Electrolitos):* creatinina: 1.01, urea: 118, potasio: 4.75, sodio: 142.3

Observaciones / Novedades:

> Interconsulta con Cardiología al alta.

Cama 10C: CHANGO GADVAY MARIA ADELAIDA

CKD-EPI: 89.3 ml/min/1.73m2

- **HC:** `1996362` | **Cédula:** 1706938626 | **Edad:** 65 años | **Sexo:** F
- **Antecedentes (APP):** Artritis reumatoide (hace 14 años); Fibromialgia; Úlcera sacra grado I

Diagnósticos Activos:

- Cuadriparesia en estudio relacionada a lesiones medulares
- Artritis reumatoide descompensada (SDAI: 10)
- Tromboembolia pulmonar superada

Soporte y Vía: - *Dieta:* Blanda fraccionada - *Hidratación / Infusiones:* Solución salina 0.9% 1000 ml + 102 mEq NaCl a 40 ml/h

Medicación Activa:

- Metilprednisolona 1 g en 250 ml SS 0.9% IV cada día (Pulso 2/5) 2/5
- Sulfato de Magnesio 1 ampolla IV c/12 horas
- Enoxaparina 80 mg SC c/12 horas

Pendientes:

- [ ] STAT **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** Pendiente resultados de RMN unión cráneo-cervical
- [ ] CONTROL **[LABORATORIO]** Control de Electrolitos y Magnesio a las 18h00 / control nocturno (`18:00 / 22:00`)
- [ ] STAT **[CUIDADO_ENFERMERIA]** Manejo urgente de dolor a nivel genital de gran intensidad (`STAT`)

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-07 (Reactantes y Hemograma):* pcr: 45.9, leucocitos: 6.21, plaquetas: 523000, potasio: 2.81

Observaciones / Novedades:

> Presentó dolor a nivel genital de gran intensidad. Staff médico convocado por déficit motor en progresión.

Cama 11A: NICOLALDE CENTENO CESAR ENRIQUE CKD-EPI: 122.2 ml/min/1.73m2

- **HC:** `554153` | **Cédula:** 1715905293 | **Edad:** 40 años | **Sexo:** M
- **Antecedentes (APP):** Síndrome de Down; Hipotiroidismo; Discapacidad intelectual 70%

Diagnósticos Activos:

- Bicitopenia en estudio (Plaquetas 13.000)
- Hipoglicemia refractaria
- Sospecha de síndrome paraneoplásico
- Infección de vías urinarias
- Hepatopatía en estudio

Soporte y Vía: - *Dieta:* Blanda para diabético con monitoreo estricto de glucosa - *Hidratación / Infusiones:* Dextrosa al 5% 1000 ml IV a 60 cc/h

Medicación Activa:

- Enoxaparina 40 mg SC cada día **[SUSPENDIDO]**

Pendientes:

- [ ] STAT **[LABORATORIO]** Monitoreo horario de glicemia capilar por hipoglicemia refractaria (`Horario (c/2 horas)`)
- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** Pendiente agendar turno Body TAC y TAC con protocolo de páncreas (Orden 34926151)

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-05 (Recuento Plaquetario):* plaquetas: 13000, leucocitos: 4.37

Observaciones / Novedades:

> Alerta plaquetopenia severa confirmada por frotis.

Cama 11B: PACHACAMA SUNTAXI FREDDY RODRIGO CKD-EPI: 75 ml/min/1.73m2

- **HC:** `20CELI84974` | **Cédula:** 1713637401 | **Edad:** 50 años | **Sexo:** M
- **Antecedentes (APP):** Lupus eritematoso sistémico (dx 2022); Anemia moderada microcítica; TEP previo; Sepsis por Salmonella superada

Diagnósticos Activos:

- Lupus eritematoso sistémico actividad alta (SLEDAI 2K: 10 puntos)
- Nefritis lúpica clase IV probable
- Derrame pleural loculado

Soporte y Vía: - *Dieta:* Blanda normoproteica - *Hidratación / Infusiones:* Vía salinizada

Medicación Activa:

- Ceftriaxona 2 g IV cada día Día 24
- Enoxaparina 60 mg SC c/12 horas
- Cotrimoxazol 800/160 mg VO Martes, Jueves, Sábado a las 14:00

Pendientes:

- [ ] STAT **[ADMINISTRATIVO_QX]** Preparación para broncoscopia y colocación de drenaje torácico MAÑANA (`STAT / NPO 24:00`)

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-01 (Control):* pcr: 29.2, leucocitos: 7.0, plaquetas: 300000, creatinina: 0.58

Observaciones / Novedades:

> Cultivo de líquido pleural: Salmonella enterica ssp enterica sensible a ceftriaxona.

Cama 12A: CALDERON ALMEIDA SIMON BOLIVAR CKD-EPI: Estadío 5 (Hemodiálisis M-J-S)

- **HC:** `2007245` | **Cédula:** 0601406994 | **Edad:** 68 años | **Sexo:** M
- **Antecedentes (APP):** Enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis trisemanal; Diabetes mellitus tipo 2; Fibrilación auricular
- **Quirúrgicos (AQX):** Catéter tunelizado yugular derecho

Diagnósticos Activos:

- Fiebre de origen no determinado en hemodiálisis

- Arritmia cardíaca
- Sospecha de bacteriemia asociada a catéter

Soporte y Vía: - *Dieta:* Dieta para paciente renal en hemodiálisis - *Hidratación / Infusiones:* Restricción hídrica estricta (no oligúrico)

Medicación Activa:

- Paracetamol 1 g IV PRN fiebre o dolor hasta c/8h

Pendientes:

- [ ] STAT **[LABORATORIO]** TOMAR HEMOCULTIVOS X 2 ANTE PICO FEBRIL + Laboratorio central de proteínas y perfil hepático (`STAT PRN`)
- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** Coordinar Body TAC para búsqueda de foco infeccioso primario

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-09 (Infeccioso y Hematológico):* leucocitos: 17.02, neutrofilos: 14.96, pcr: 53.3, procalcitonina: 0.97, inr: 1.89

Observaciones / Novedades:

> Leucocitosis de 17.020 con PCR 53.30.